EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 94495
SERVICIO : UNIDAD EMERGENCIAS
FECHA : 2024-10-09 14:18:36

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARGARITA INES MELLA POBLETE			RUN	: 8.837.974-8
F.Nac	: 29-01-1963	Edad	: 61 AÑOS, 8 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: EL SAUCE			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 975121632		
Fecha Ingreso	: 08-10-2024	Fecha Egreso	: 2024-10-09 14:18:36	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	: COMUNIDAD TERAPEUTICA

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. G93.4-ENCEFALOPATIA NO ESPCIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Cirrosis Hepática: Probablemente secundaria a MAFLD, Child A6, MELD 11, MELD-Na 15.
Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2)

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. G93.4-ENCEFALOPATIA NO ESPCIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

ANAMNESIS:
MC. DECAIMIENTO
ANTECEDENTES: HTA, DM2IR, FA, DEPRESION, DHC CHILD C NO OH,VARICES ESOFAGICAS.
ALERGIAS: DICLOFENACO
MEDICAMENTOS: FRS1-0/ ESPIRO 2-0/ CVD 6.25 1-1/ NPH 34-30 U / OMP 1-0
ESTUVO HOSPITALIZADA POR CUADRO DE PERITONITIS BACTERIANAN ESPONTANEA, TRAIDA ACTUALMENTE POR FAMILIARES POR CUADRO DE GLICEMIA ELEVADAS Y MAYOR COMPROMISO DEL ESTADO GENERAL Y COMPROMISO DE CONCIENCIA., HACE 24 HORAS CON EPISODIOS DIARREICOS/EXAMEN LAB
GLICEMIA 524 K 5.20 UREA 94 NA 129 OSMOLARIDAD 302
GSA 7.52 PCO2 28.7 HCO3: 23 (ALCALOSIS RESPIRATORIA AGUDA) CREAT 0.90 BT 3.10 BD 2.33 FA 362

LACTATO 2.8 LIPASA 977 TG 107 HB 8.0 LEUCO 5.50 INR 1.40 TROPO 4.2

ECG SINUSAL, SIN SSDST

/PACIENTE EN BOX, CON HEMOGLUCOTEST 226, MANTIENE ALTERACION DEL SENSORIO (SOMNOLENCIA SUPERFICIAL) /Antecedentes de cirrosis hepática CHILD P C ingresó con hiperglicemia compromiso de conciencia. Se realizó corrección sin necesidad de paracentesis (fines agosto PBE S. oralis). La función renal conservada, manejo ambulatorio con r bajo en sal y normoproteico Lactulosa, PEG, furosemida, espironolactona, ciprofloxacino, carvedilol, insulina NPH, omeprazol.
NEUROLGICO_ SOMNOLENCIA SUPERFICIAL, OBEDECE ORDENES, EXTREMIDADES MOVILES, SIN ALTERACIONDE PARES CRANEALES MOTORES
MUCOSAS ORALES SECAS
CUELLO MOVIL SIMETRICO, YUGULARES NO VIISBLES
TORAX MV +SRA NOTA : TR NEGATIVO APRA HDA
ANTECEDENTES:
DM: (+) Otros: Cirrosis Hepática: Probablemente secundaria a MAFLD, Child A6, MELD 11, MELD-Na 15. Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2): Mal control metabólico. Psoriasis y Osteoporosis. PBE TRATADA RECIENTEMENTE

Alergias: No Farmacos: No

SIGNOS VITALES:
PA: 135/74 mmHg FC: 0 x/min T°Ax: 36.7°C T°Rec: °C HGT: 514 mg/dL Sat.: 98%
GCS: 0 ptos. FR: 0 x/min Peso: Kg Talla: cm Score de Tal: ptos.
EXAMEN FISICO:
NEUROLGICO_ SOMNOLENCIA SUPERFICIAL, OBEDECE ORDENES, EXTREMIDADES MOVILES, SIN ALTERACIONDE PARES CRANEALES MOTORES

MUCOSAS ORALES SECAS
CUELLO MOVIL SIMETRICO, YUGULARES NO VIISBLES
TORAX MV +SRA

Cabeza: Normal

Tórax: Normal

Pulmonar: Normal

Cardiaco: Normal

Abdomen: Normal

Extremidades: Normal

Neurológico: Normal

Columna: Normal

Genitales: Normal

Otros:

HIPOTESIS DIAGNOSTICA
ENCEFALOPATIA NO ESPCIFICADA
Cirrosis Hepática: Probablemente secundaria a MAFLD, Child A6, MELD 11, MELD-Na 15.
Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2): Mal control metabólico.
Psoriasis y Osteoporosis.
PBE TRATADA RECIENTEMENTE
INDICACIONES
HOSPITALIZAR EN AGUDOS
RÉGIMEN CERO POR BOCA
SI ES POSIBLE ALIMENTAR RÉGIMEN CON RESTRICCIÓN DE PROTEÍNAS
SF0,9% 40 CC HORA
ENEMA DE LACTULOSA 300 CC MAS 200 CC DE AGUA CADA 8 HORAS
RIFAXIMINA DE 200 2 CADA 8 HORAS ó CIPROFLOXACINO 500MG 1 AL DIA VO
CEFTRIAXONA 2 G EV CADA HORAS
FUROSEMIDA 40MG EN LA MAÑANA
ESPIRONOLACTONA 50MG EN LA MAÑANA
CARVEDILOL 6.25MG CADA 12 H VO
INSULINA NPH 20 U EN LA MAÑANA Y 20 U EN LA NOCHE
OMEPRAZOL 20MG 1 AL DIA VO
CONTROL RESIDENTE CON TAC
INSULINA CRISTALINA SC 151-200 MG/DL 2UI; 201-250MG/DL:4UI; 251-300MG/DL:6UI 301-350MG/DL:8UI > 300MG/DL:10UI
HGT CADA 6 HORAS

PLAN DE MANEJO:

CEFTRIAXONA 2 GR EV CADA DIA POR 7 DIAS
CIPROFLOXACINO COMP 500 MG TOMAR CADA DIA VO POR 7 DIAS
LACTULOSA FRASCO TOMAR 20CC CADA DIA POR 5 DIAS

INDICACIONES AL ALTA

1. CSV CADA DIA
2. CONTROL HGT CADA DIA
3. CEFTRIAXONA 2 GR EV CADA DIA POR 7 DIAS
4. CIPROFLOXACINO COMP 500 MG TOMAR CADA DIA VO POR 7 DIAS
5. LACTULOSA FRASCO TOMAR 20CC CADA DIA POR 5 DIAS

OBSERVACIONES:

TAC DE CEREBRO : SIN HALLAZGOS PATOLOGICOS
TAC ABD. Y PELVIS DAÑO HEPATICO CRONICO CON ELEMENTOS DE HIPERTENSION PORRTAL (ESPLENOMEGALEA, ASCITIS, EDEMA VASCULAR, COLOPATIA PORTAL , CIRCULACION PORTOSISTEMICA), LESIONES FOCALES HIPERVASCULARES PERIVESICULARES , QUE SUGIERE EVALUAR CON RM
COLELITIASIS .

MEDICO TRATANTE

JEFE SERVICIO